Entraînement QCM — Théorie de gestion des symptômes

UE A1 — TD d'application • 40 questions • cinq propositions A à E

Pour chaque question, cochez **une à trois réponses correctes**. Les corrigés argumentés figurent après toutes les questions.

Niveaux d'entraînement : 12 faciles • 16 intermédiaires • 12 difficiles. La difficulté est indicative, et non une cotation officielle de partiel.

Fondements et modèles

Q01. Quel est le rôle principal de la théorie de gestion des symptômes (TGS) ? FACILE

- ☐ **A.** Décrire uniquement les manifestations biologiques sans explorer le vécu.
- ☐ **B.** Comprendre le vécu des symptômes et leur gestion.
- ☐ **C.** Remplacer le jugement clinique.
- ☐ **D.** Déterminer à elle seule le diagnostic médical.
- ☐ **E.** Écarter le contexte de vie.

Q02. À quelle catégorie de théorie appartient la théorie de gestion des symptômes (TGS) ? FACILE

- ☐ **A.** Une théorie intermédiaire.
- ☐ **B.** Un modèle conceptuel général centré sur les besoins.
- ☐ **C.** Un modèle clinique organisant le jugement en trois axes.
- ☐ **D.** Une démarche de prise de décision standardisée.
- ☐ **E.** Une théorie exclusivement consacrée au diagnostic médical.

Q03. Quels éléments font partie des quatre piliers du métaparadigme infirmier ? FACILE

- ☐ **A.** La personne.
- ☐ **B.** L'environnement.
- ☐ **C.** Le modèle clinique trifocal.
- ☐ **D.** La santé / maladie.
- ☐ **E.** Les 14 besoins fondamentaux.

Q04. Quelle proposition différencie correctement trois approches étudiées ? DIFFICILE

- ☐ **A.** Henderson aide à analyser besoins et autonomie.
- ☐ **B.** La TGS analyse d'abord l'autonomie dans chacun des 14 besoins.
- ☐ **C.** Le trifocal organise le jugement clinique.
- ☐ **D.** Les trois approches doivent être appliquées dans un ordre obligatoire.
- ☐ **E.** Le trifocal ne distingue pas risques et réactions humaines réelles.

Q05. Quel usage des modèles de Henderson, de la TGS et du trifocal est pertinent pour analyser une situation clinique ? FACILE

- ☐ **A.** Appliquer une seule grille à toutes les situations sans choix.
- ☐ **B.** Les mobiliser comme des regards complémentaires selon la situation.
- ☐ **C.** Ignorer l'expérience de la personne.
- ☐ **D.** Réserver obligatoirement le trifocal aux seules maladies chroniques.
- ☐ **E.** Ne jamais associer besoins et symptômes.

Expérience et facteurs

Q06. Quels sont les trois éléments examinés dans l'expérience d'un symptôme ? FACILE

- ☐ **A.** Perception.
- ☐ **B.** Évaluation.
- ☐ **C.** Vécu / réponse.
- ☐ **D.** Stratégie de gestion choisie par le soignant.
- ☐ **E.** Résultat observé après intervention.

Q07. Deux personnes attribuent la même note à une douleur. Que peut-on conclure ? FACILE

- ☐ **A.** Leur vécu est obligatoirement identique.
- ☐ **B.** Leur contexte peut modifier leur expérience.
- ☐ **C.** Leur émotion est toujours la même.
- ☐ **D.** Une note suffit à comprendre le retentissement social.
- ☐ **E.** L'évaluation infirmière est inutile.

Q08. Une étudiante reconnaît les premiers signes d'une migraine. Quelle donnée décrit surtout la perception du symptôme ? DIFFICILE

- ☐ **A.** Elle ressent un début de douleur sur un côté de la tête.
- ☐ **B.** Elle note habituellement 8/10.
- ☐ **C.** Elle estime la crise plus fréquente.
- ☐ **D.** Elle déclare qu'elle ne pourra pas finir sa journée.
- ☐ **E.** Elle suit un plan proposé par l'infirmière.

Q09. Quelle donnée illustre le vécu / la réponse au symptôme ? INTERMÉDIAIRE

- ☐ **A.** L'existence de contraintes universitaires.
- ☐ **B.** L'inquiétude de perdre une journée de révision.
- ☐ **C.** Le constat de cinq crises dans un mois.
- ☐ **D.** La douleur pulsatile qui augmente.
- ☐ **E.** L'exposition prolongée aux écrans.

Q10. Chez une étudiante vivant avec des migraines récurrentes, quelles données peuvent influencer le vécu des symptômes ? INTERMÉDIAIRE

- ☐ **A.** Ses expériences antérieures de migraines.
- ☐ **B.** Ses contraintes d'examens.
- ☐ **C.** Son environnement de travail.
- ☐ **D.** Une valeur de laboratoire non fournie.
- ☐ **E.** Un traitement inventé.

Q11. Comment faut-il interpréter le classement interne / externe d'un facteur ? DIFFICILE

- ☐ **A.** Il doit toujours être unique et incontestable.
- ☐ **B.** On cherche surtout ses interactions et son intérêt clinique.
- ☐ **C.** Il est interdit de noter un facteur mixte.
- ☐ **D.** L'environnement n'a aucun rôle.
- ☐ **E.** Le classement remplace l'entretien.

Q12. Une étudiante souffre de migraines récurrentes et cumule études et travail. Quels éléments sont des facteurs de contexte pertinents ? DIFFICILE

- ☐ **A.** Le sommeil et la fatigue.
- ☐ **B.** Les études et les examens.
- ☐ **C.** Les pauses et les repas sautés.
- ☐ **D.** Une maladie cardiaque déjà diagnostiquée.
- ☐ **E.** Un trouble visuel confirmé.

Q13. Quelle affirmation décrit correctement les liens entre personne et environnement ? INTERMÉDIAIRE

- ☐ **A.** Ils sont indépendants en toutes circonstances.
- ☐ **B.** Ils interagissent et peuvent modifier le vécu.
- ☐ **C.** L'environnement n'influence que les maladies infectieuses.
- ☐ **D.** Seules les données médicales sont pertinentes.
- ☐ **E.** Le travail ne peut jamais intervenir.

Clusters et situation Émilie

Q14. Qu'appelle-t-on un cluster de symptômes ? FACILE

- ☐ **A.** Un seul symptôme mesuré plusieurs fois.
- ☐ **B.** Un groupe de manifestations coexistantes ou interagissant.
- ☐ **C.** Une complication toujours grave.
- ☐ **D.** Un diagnostic médical obligatoire.
- ☐ **E.** Un plan de prévention administratif.

Q15. Une étudiante ressent lors de ses migraines des signes physiques et émotionnels associés. Lesquels peuvent former un groupe de symptômes ? FACILE

- ☐ **A.** Nausées.
- ☐ **B.** Gêne à la lumière et au bruit.
- ☐ **C.** Fatigue et inquiétude.
- ☐ **D.** Fracture confirmée.
- ☐ **E.** Insuffisance cardiaque confirmée.

Q16. Pourquoi ne faut-il pas se limiter à la note de douleur ? DIFFICILE

- ☐ **A.** Elle ne renseigne pas seule sur les symptômes associés et l'impact.
- ☐ **B.** Toute douleur cotée est fausse.
- ☐ **C.** Les autres symptômes ne doivent pas être demandés.
- ☐ **D.** Une intensité élevée garantit à elle seule le diagnostic de migraine.
- ☐ **E.** Elle rend la TGS inutile.

Q17. Une étudiante avait habituellement une à deux migraines par mois. Quel changement récent doit attirer l'attention ? INTERMÉDIAIRE

- ☐ **A.** Les crises passent d'environ 1–2 par mois à cinq sur un mois.
- ☐ **B.** Sa filière universitaire change.
- ☐ **C.** Elle a 22 ans.
- ☐ **D.** Elle travaille en magasin.
- ☐ **E.** Elle consulte l'infirmière pour la première fois dans ce récit.

Q18. Une patiente rapporte des migraines devenues plus fréquentes. Quelle attitude est justifiée ? DIFFICILE

- ☐ **A.** Évaluer l'évolution et rechercher des éléments d'alerte.
- ☐ **B.** Attribuer d'emblée toutes les crises aux examens.
- ☐ **C.** Garantir l'absence de problème médical.
- ☐ **D.** Conseiller sans recueillir les signes associés.
- ☐ **E.** Affirmer une origine psychologique certaine.

Q19. Une étudiante subit une forte charge de travail et des crises migraineuses répétées. Quelle proposition traduit une boucle d'auto-entretien possible ? INTERMÉDIAIRE

- ☐ **A.** Crises, travail perturbé et stress peuvent se renforcer.
- ☐ **B.** Un repas sauté suffit à prouver la cause de toutes les crises.
- ☐ **C.** Le stress n'a aucune relation possible avec le vécu.
- ☐ **D.** Le travail résout systématiquement les crises.
- ☐ **E.** Une crise exclut toute interaction avec le contexte.

Autogestion et stratégies

Q20. Une étudiante souffre de migraines récurrentes et connaît un traitement de crise prescrit. Quelles conduites constituent des stratégies d'autogestion ?

DIFFICILE

- ☐ **A.** S'isoler dans le calme et l'obscurité.
- ☐ **B.** Tenter de se reposer.
- ☐ **C.** Utiliser son traitement prescrit conformément aux indications.
- ☐ **D.** Changer seule la dose prescrite.
- ☐ **E.** Écarter tout recours aux soins.

Q21. Quelle distinction est correcte ?

FACILE

- ☐ **A.** Autonomie avec traitement prescrit = automédication par définition.
- ☐ **B.** Une personne peut gérer de façon autonome une prescription connue.
- ☐ **C.** Une prescription « si besoin » ne nécessite aucune évaluation.
- ☐ **D.** L'autonomie interdit le suivi médical.
- ☐ **E.** Seuls les professionnels peuvent mettre en œuvre des auto-soins.

Q22. Lorsqu'une prescription mentionne « si besoin », quelle attitude infirmière est adaptée ?

INTERMÉDIAIRE

- ☐ **A.** Évaluer le besoin et appliquer les conditions précisées.
- ☐ **B.** Administrer sans lire les conditions.
- ☐ **C.** Inventer un seuil non prescrit.
- ☐ **D.** Ignorer le contexte clinique.
- ☐ **E.** Modifier automatiquement la posologie.

Q23. Une étudiante souffrant de migraines récurrentes constate que ses stratégies habituelles sont devenues insuffisantes. Quel motif justifie sa consultation ?

DIFFICILE

- ☐ **A.** Ses stratégies habituelles ne suffisent plus à maîtriser le retentissement.
- ☐ **B.** Elle n'a jamais connu de migraine.
- ☐ **C.** Un nouveau diagnostic neurologique a été confirmé.
- ☐ **D.** Elle souhaite arrêter toutes ses études.
- ☐ **E.** Elle n'a jamais essayé d'auto-soins.

Q24. Quelles questions aident à apprécier une stratégie de gestion ?

INTERMÉDIAIRE

- ☐ **A.** Qu'est-ce qui a été tenté ?
- ☐ **B.** Quand et comment ?
- ☐ **C.** Avec quels effets ?
- ☐ **D.** Quel est le numéro de chambre si aucun séjour hospitalier ?
- ☐ **E.** Évaluer seulement l'action médicamenteuse, sans son effet sur la vie.

Entretien infirmier et sécurité

Q25. Lorsqu'une étudiante consulte pour des migraines récurrentes, quelle première posture infirmière est pertinente ? FACILE

- ☐ **A.** Demander à la patiente de raconter le déroulement d'une crise.
- ☐ **B.** Prescrire immédiatement une liste de changements.
- ☐ **C.** Réduire l'entretien à une note de douleur.
- ☐ **D.** Lui reprocher son emploi du temps.
- ☐ **E.** Écarter toute inquiétude exprimée.

Q26. Quelles informations doivent être explorées dans l'entretien ? INTERMÉDIAIRE

- ☐ **A.** Fréquence, durée et intensité des épisodes.
- ☐ **B.** Signes associés et retentissement.
- ☐ **C.** Contexte, stratégies essayées et résultats.
- ☐ **D.** Uniquement la profession de la patiente.
- ☐ **E.** Uniquement sa date de naissance.

Q27. À quoi peut servir un carnet de suivi ? DIFFICILE

- ☐ **A.** Repérer des régularités à discuter avec la personne.
- ☐ **B.** Établir à lui seul une causalité certaine.
- ☐ **C.** Remplacer toute évaluation clinique.
- ☐ **D.** Prouver qu'aucune orientation n'est nécessaire.
- ☐ **E.** Prescrire un traitement nouveau.

Q28. Quel élément justifie d'envisager une orientation vers un autre professionnel ? INTERMÉDIAIRE

- ☐ **A.** Des signes d'alerte ou des limites du champ de compétences.
- ☐ **B.** Toute demande de pause au travail.
- ☐ **C.** L'existence d'un examen universitaire.
- ☐ **D.** Une préférence de la patiente pour un horaire.
- ☐ **E.** La seule existence d'un carnet.

Adhésion et co-construction

Q29. Dans un projet de gestion des symptômes, que signifie l'adhésion du patient ? INTERMÉDIAIRE

- ☐ **A.** Obtenir l'obéissance à des consignes imposées.
- ☐ **B.** Rechercher un projet accepté, compris et faisable avec la personne.
- ☐ **C.** Imposer le même objectif à tous les patients.
- ☐ **D.** Supprimer tout compromis.
- ☐ **E.** Refuser le dialogue.

Q30. Une étudiante doit concilier gestion des migraines, études et travail. Quel exemple illustre la co-construction du projet de soins ? INTERMÉDIAIRE

- ☐ **A.** L'inviter à choisir un changement compatible avec ses obligations.
- ☐ **B.** Lui imposer un programme irréalisable.
- ☐ **C.** Ignorer sa contrainte financière.
- ☐ **D.** Définir seul ses priorités.
- ☐ **E.** Menacer d'interrompre l'aide si elle refuse.

Q31. Pourquoi un conseil général peut-il échouer malgré sa bonne intention ? FACILE

- ☐ **A.** Il peut être difficilement applicable et fragiliser la confiance.
- ☐ **B.** Il est toujours sans intérêt dans tous les contextes.
- ☐ **C.** Il dispense de tout objectif.
- ☐ **D.** Il remplace la relation de soin.
- ☐ **E.** Il impose une réussite immédiate.

Q32. Une étudiante souhaite limiter ses migraines en conservant ses études et son travail. Quels changements modestes et réalisables peuvent être négociés ? INTERMÉDIAIRE

- ☐ **A.** Prévoir un déjeuner plutôt que le sauter.
- ☐ **B.** Faire des pauses au cours des longues séances sur ordinateur.
- ☐ **C.** Abandonner obligatoirement les études.
- ☐ **D.** Augmenter librement le traitement.
- ☐ **E.** Arrêter toute activité professionnelle immédiatement.

Q33. Si une patiente refuse une proposition de soin, quelle démarche est cohérente ? DIFFICILE

- ☐ **A.** Explorer les raisons, négocier et ajuster si possible.
- ☐ **B.** Passer outre son choix sans discussion.
- ☐ **C.** Considérer tout refus comme une mauvaise volonté.
- ☐ **D.** Maintenir l'objectif quelles que soient ses contraintes.
- ☐ **E.** Cesser systématiquement de communiquer.

Résultats et réévaluation

Q34. Chez une étudiante dont les migraines perturbent les études et le quotidien, quel résultat de soins serait pertinent ? INTERMÉDIAIRE

- ☐ **A.** Réduire le retentissement des crises sur son quotidien.
- ☐ **B.** Garantir la disparition immédiate de toute migraine.
- ☐ **C.** Supprimer les examens universitaires.
- ☐ **D.** Obtenir une obéissance parfaite.
- ☐ **E.** Éviter tout suivi.

Q35. Quels indicateurs pourraient aider à réévaluer une stratégie ? INTERMÉDIAIRE

- ☐ **A.** Nombre de crises sur une période.
- ☐ **B.** Intensité et durée rapportées.
- ☐ **C.** Gêne dans les études et les activités.
- ☐ **D.** Une valeur fictive choisie pour plaire au soignant.
- ☐ **E.** Le seul nombre de conseils donnés.

Q36. Pourquoi faut-il prévoir une nouvelle évaluation après la mise en œuvre ? FACILE

- ☐ **A.** Pour vérifier les effets et ajuster le projet.
- ☐ **B.** Pour éviter de demander l'avis de la personne.
- ☐ **C.** Parce qu'un plan ne peut jamais évoluer.
- ☐ **D.** Pour prouver qu'une hypothèse initiale est toujours vraie.
- ☐ **E.** Pour ignorer l'éventuelle aggravation.

Q37. Quel enchaînement correspond au raisonnement décrit ? DIFFICILE

- ☐ **A.** Recueil → compréhension → co-construction → mise en œuvre → évaluation.
- ☐ **B.** Conseil imposé → abandon de l'entretien → absence de suivi.
- ☐ **C.** Traitement inventé → conclusion → recueil.
- ☐ **D.** Évaluation des résultats avant toute intervention, sans données.
- ☐ **E.** Classement des symptômes sans examiner le vécu.

Comparaisons et application

Q38. Quelle donnée entre surtout dans les réactions humaines réelles du modèle trifocal ? INTERMÉDIAIRE

- ☐ **A.** L'inquiétude rapportée par Émilie face aux crises.
- ☐ **B.** Une complication non survenue présentée comme certaine.
- ☐ **C.** Une pathologie inventée.
- ☐ **D.** Une prescription hypothétique.
- ☐ **E.** Un risque pris pour une réaction déjà observée.

Q39. Quel énoncé décrit correctement les risques dans le modèle trifocal ? DIFFICILE

- ☐ **A.** Ils sont à anticiper ; ils ne sont pas tous déjà réalisés.
- ☐ **B.** Ils sont synonymes de symptômes présents.
- ☐ **C.** Ils n'ont aucun lien avec les données recueillies.
- ☐ **D.** Ils remplacent le diagnostic médical.
- ☐ **E.** Ils ne concernent jamais la sécurité.

Q40. Pour analyser une situation clinique avec la théorie de gestion des symptômes, quelle méthode choisir ? INTERMÉDIAIRE

- ☐ **A.** Identifier faits, facteurs, vécu et stratégies puis justifier les réponses.
- ☐ **B.** Mémoriser exclusivement le nom des trois modèles.
- ☐ **C.** Éviter de prendre en compte l'environnement.
- ☐ **D.** Confondre hypothèse et certitude.
- ☐ **E.** Répondre sans relire les données du cas.

Corrigés argumentés

Les lettres indiquées sont les seules réponses justes pour chaque question. Les explications reprennent les notions du TD et du CM4.

Fondements et modèles

Q01 — Réponse(s) : B. La TGS aide à comprendre comment la personne ressent, gère et réévalue ses symptômes, dans un contexte donné.

Q02 — Réponse(s) : A. La TGS est une théorie intermédiaire centrée sur l'expérience et la gestion des symptômes.

Q03 — Réponse(s) : A + B + D. Les piliers enseignés sont personne, environnement, santé / maladie et soin.

Q04 — Réponse(s) : A + C. Henderson cible besoins et autonomie ; la TGS le vécu des symptômes ; le trifocal structure les données.

Q05 — Réponse(s) : B. Ces modèles et cette théorie apportent des regards complémentaires et non interchangeables.

Expérience et facteurs

Q06 — Réponse(s) : A + B + C. L'expérience du symptôme comporte sa perception, son évaluation et son vécu ou réponse.

Q07 — Réponse(s) : B. Une intensité égale ne garantit pas un vécu ou un retentissement identiques.

Q08 — Réponse(s) : A. La perception concerne ce qu'elle ressent et reconnaît ; score et impact relèvent plutôt de l'évaluation.

Q09 — Réponse(s) : B. L'inquiétude exprime ce que la crise signifie dans sa vie.

Q10 — Réponse(s) : A + B + C. L'histoire des crises, les examens et les obligations professionnelles peuvent modifier le vécu ; aucun diagnostic nouveau ne doit être présumé.

Q11 — Réponse(s) : B. Les facteurs internes et externes interagissent : il importe surtout d'identifier leur influence.

Q12 — Réponse(s) : A + B + C. Les caractéristiques personnelles et les contraintes du quotidien constituent des facteurs contextuels ; les diagnostics non établis ne peuvent être supposés.

Q13 — Réponse(s) : B. La personne et son environnement peuvent s'influencer mutuellement.

Clusters et situation Émilie

Q14 — Réponse(s) : B. Un cluster regroupe plusieurs symptômes et leur retentissement possible.

Q15 — Réponse(s) : A + B + C. Un groupe de symptômes peut associer manifestations physiques et émotionnelles ; un diagnostic non établi ne doit pas être ajouté.

Q16 — Réponse(s) : A. Une note d'intensité isolée ne renseigne pas sur les signes associés, les changements ni le retentissement.

Q17 — Réponse(s) : A. La modification récente de fréquence est une donnée importante à réévaluer.

Q18 — Réponse(s) : A. Il faut évaluer le changement et ne pas transformer des hypothèses contextuelles en diagnostic.

Q19 — Réponse(s) : A. La boucle d'auto-entretien est une interprétation des interactions, non la preuve d'une causalité isolée.

Autogestion et stratégies

Q20 — Réponse(s) : A + B + C. La patiente utilise des auto-soins et une prescription connue ; changer seule une dose n'est pas décrit.

Q21 — Réponse(s) : B. L'utilisation autonome d'un traitement prescrit, dans les conditions définies, ne se confond pas avec l'automédication.

Q22 — Réponse(s) : A. Une prescription « si besoin » implique l'évaluation du besoin et le respect des conditions précisées.

Q23 — Réponse(s) : A. La demande de soin s'explique par l'insuffisance de ses stratégies habituelles dans une situation devenue plus gênante.

Q24 — Réponse(s) : A + B + C. La TGS explore l'action et ses modalités puis les résultats effectivement perçus.

Entretien infirmier et sécurité

Q25 — Réponse(s) : A. L'écoute et le récit du vécu précèdent les conseils et la co-construction.

Q26 — Réponse(s) : A + B + C. L'entretien doit couvrir les caractéristiques des épisodes, les signes associés, le contexte et les stratégies.

Q27 — Réponse(s) : A. Le carnet facilite l'observation des contextes, mais ne suffit pas à prouver une cause ni à écarter des risques.

Q28 — Réponse(s) : A. La sécurité du patient impose de repérer les signes d'alerte et de solliciter une orientation adaptée.

Adhésion et co-construction

Q29 — Réponse(s) : B. L'adhésion suppose un projet compris, co-construit, accepté et réalisable.

Q30 — Réponse(s) : A. La négociation respecte les priorités et capacités réelles de la patiente.

Q31 — Réponse(s) : A. Des conseils non adaptés peuvent être perçus comme irréalistes et décourageants.

Q32 — Réponse(s) : A + B. Le compromis porte sur des changements modestes, concrets et négociés.

Q33 — Réponse(s) : A. Face au refus, la démarche repose sur l'écoute des raisons, la négociation et l'adaptation.

Résultats et réévaluation

Q34 — Réponse(s) : A. Un résultat réaliste peut porter sur la fréquence, l'intensité ou le retentissement des migraines.

Q35 — Réponse(s) : A + B + C. La réévaluation doit concerner les manifestations et leurs conséquences pour la personne.

Q36 — Réponse(s) : A. La TGS décrit un processus dynamique : résultats et objectifs sont réexaminés.

Q37 — Réponse(s) : A. Le cours développe une démarche d'exploration, de plan partagé et de réévaluation.

Comparaisons et application

Q38 — Réponse(s) : A. Les réactions réelles sont des réponses effectivement présentes, comme l'inquiétude exprimée.

Q39 — Réponse(s) : A. Le modèle distingue les risques potentiels des problèmes et réactions effectivement présents.

Q40 — Réponse(s) : A. L'analyse clinique mobilise les facteurs, le vécu et les stratégies de gestion pour justifier les réponses.